

柳叶刀 | 睡眠限制疗法是治疗慢性失眠的简单有效方法，且可由护士实施

 柳叶刀TheLancet
2023-08-25 12:35 发布于北京 柳叶刀TheLancet官方账号

+关注

慢性失眠（Chronic insomnia）是一个重大公共卫生问题。约30%的人对自身睡眠不满意，约10%的人患有《精神障碍诊断与统计手册（第五版）》定义的失眠障碍（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5-defined insomnia disorder），该障碍伴有日间功能损伤。[1] 有迹象表明，在向初级卫生保健（primary care）医生咨询的患者中，失眠的报告率甚至高达50%。由于患者不提，初级卫生保健医生也未识别出，失眠这一问题往往被忽视。[2] 如果患者接受治疗，那么他们大多数将接受催眠药物治疗（高达60%）[3]，这种治疗方法在短期内有效，但长期效果尚未得到证实。根据目前的指南，首选治疗方法为失眠认知行为疗法（CBTi），它由不同的部分组成。[4]但问题是，接受完整CBTi的患者不足1%。[5]

为何CBTi的实施如此困难？首先，在许多国家，将患者转诊至心理医生存在限制。训练有素的心理医生数量不足，心理健康服务的轮候名单（waiting lists）很长。解决方法是在初级卫生保健中提供CBTi。[2] 然而，据初级保健医生报告，他们自身缺乏提供CBTi的时间和知识。由于这一需求尚未得到满足，出现了一些简化治疗和使用护士而非医生提供CBTi的举措。一个例子是在指导下接受线上治疗（guided online treatments）。许多研究显示，这种线上治疗的效果很好[6]，并且护士也可以在初级卫生保健中成功提供这种治疗。[7]但是，与大多数线上治疗一样，在常规卫生保健中提供线上治疗的应用仍有限[8]。因此，我们赞赏为证明一种易于使用、有时限的失眠治疗方法的有效性所做的努力。

Simon D Kyle及其同事[9]在《柳叶刀》（The Lancet）上发表的论文介绍了**睡眠限制疗法（sleep restriction therapy）**随机对照试验的结果，**该疗法被认为是CBTi中最积极、有效的方法**。[10]该研究在英国的35个全科诊所进行，共642例失眠障碍患者参加。患者平均年龄为55.4岁（IQR 15.9岁，范围19-88岁），489例（76.2%）参与者为女性，153例（23.8%）参与者为男性，624例（97.2%）参与者为白种人。患者被随机分配到干预组（n=321）和对照组（n=321），干预组接受睡眠卫生和由护士提供的四次睡眠限制疗法，对照组只接受睡眠卫生。接受睡眠限制疗法的患者中约有三分之二（207例 [64.5%]）完成了全部四次治疗。主要分析结果显示，基线6个月后用失眠严重程度指数（Insomnia Severity Index）测量的失眠严重程度差异产生了较大效应（Cohen's d -0.74；P<0.0001；支持干预）。**在6个月的随访中，提供数据的患者中，睡眠限制疗法组的257例患者中有108例（42.0%）符合临床治疗反应标准，而对照组的291例患者中有49例（16.8%）符合临床治疗反应标准。**

这是否意味着睡眠限制疗法是在初级卫生保健中提供有效治疗的最终解决方案？我们认为研究结果很有希望，确实应该实施睡眠限制疗法。同时，也有一些缺点需要考虑。首先是样本的代表性。该试验中的患者不仅通过初级卫生保健医生的转诊招募，

热门应用推荐

 腾讯新闻·电脑版
全网热点早知道

NEW 点击下载

 腾讯桌面整理
一款智能分类桌面软件

点击下载

精选视频

当前设备不支持播放
你可以 **刷新** 试试
70017001.203-b0fbcfbceeb842882f9b3baf75737802

高市早苗G20峰会上演外交灾难：会...

美乌欧日内瓦会谈 各方分歧明显

李在明：当前韩朝关系处于极其危险状...

美国将所谓贩毒集团列为“恐怖组织”

中央气象台：强冷空气密集来袭影响我...

热点榜

榜单规则说明

换一换

习近平同美国总统特朗普通电话

1 神舟二十二号飞船发射圆满成功

2 中超3队哄抢巴甲强力边锋 **新**

3 科技实力迈上新台阶

4 解放军报：一切后果，日方承担！

5 46岁女子腹痛3天因节育器异位 **▶**

6 网警揭露直播间“托儿”真面目

7 中院刑庭庭长醉驾被免职 媒体锐评

8 美乌又整了份“19点和平计划”

9 万科已全部出售贝壳股票 **新**

10 腹泻就吃抗生素，好得快？ **辟谣**

 腾讯新闻·电脑版
24小时陪你追热点

点击下载

首页

刷新

反馈

更多

作者其他文章

还通过搜索临床记录和发送邮件的方式招募（百分比未知）。所有患者都愿意参与研究，并在完成调查问卷后获得代金券。这种方法可能意味着参与研究的患者与在日常诊疗中主动寻求帮助的患者有所不同。我们不知道参与者与常规治疗中确诊的患者在多大程度上相似或不同。其次，该试验并未解决初级卫生保健医生无法识别失眠的问题，因此在常规治疗中实施睡眠限制疗法可能仍然令人失望。第三，研究中的患者大多是白种人，来自贫困程度较低地区，近一半拥有大学学位。黑种人和社会经济地位较低的人所占比例较低，未得到充分代表，在CBTi实施时可能无法获得该治疗。总体而言，针对缺乏医疗服务人群的CBTi研究还很少。[11] 我们迫切需要改善这种研究稀缺的状况，因为针对不同文化背景的干预措施确实能提高干预措施的依从性，而依从性的提高与更好的治疗效果相关。[12]

Kyle及其同事的研究[9]表明，**睡眠限制疗法至少对部分慢性失眠患者来说是一种简单而有效的治疗方法，并且可以由初级卫生保健中的护士实施。**这对于应对失眠的公共卫生负担具有重要贡献。当务之急是为无法得到充分服务的人群调整治疗方法，并培养初级卫生保健人员识别失眠的能力。 **END**

作者介绍及声明（滑动查看更多）

Annemieke van Straten*, Shanna van Trigt, Jaap Lancee

a.van.straten@vu.nl

Department of Clinical, Neuro, and Developmental psychology, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, Netherlands (AvS); Amsterdam University Medical Centres, Vrije Universiteit, Amsterdam, Netherlands (SvT); Department of Psychiatry and Department of Clinical Psychology, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands (JL)

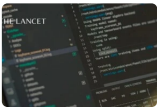
AvS and JL developed the online insomnia intervention i-Sleep, which is an online intervention containing the evidence-based cognitive behavioral therapy for insomnia. AvS holds IP of this i-Sleep intervention. The intervention is commercially available to health-care professionals through minddistrict.com, the authors do not receive any income from this collaboration. The content of i-sleep is also freely available in an e-book format. The intervention is also commercially available to health-care professionals through leerslapen.nl, which is owned by a clinic specialised in treating sleep problems (Kempenhaghe, Heeze, Netherlands). A small return of investment is received from this collaboration with Kempenhaghe by Vrije Universiteit Amsterdam, the university which employs AvS, this return of investment is used to update and maintain the intervention.SvT declares no competing interests.

参考资料（滑动查看更多）

[1]. Morin CM, Jarrin DC. Epidemiology of insomnia: prevalence, course, risk factors, and public health burden. Sleep Med Clin 2022; 17: 173–91.



柳叶刀 | 在AI时代重拾医学人文关怀
22小时前



视频 | AI会取代我的医生吗?
1评论 11-21



救命！这游戏0氪金竟能横扫全图？爆装打金爽到飞...
广告 超变魔幻打... 了解详情 ×



每人仅限领1个
送瑞幸葫芦杯
立即领取

终于等到了，今天下单就送保温杯！

- 首页
- 刷新
- 反馈
- 更多

[2]. Ogeil RP, Chakraborty SP, Young AC, Lubman DI. Clinician and patient barriers to the recognition of insomnia in family practice: a narrative summary of reported literature analysed using the theoretical domains framework. *BMC Fam Pract* 2020; 21: 1.

[3]. Baglioni C, Altena E, Bjorvatn B, et al. The European Academy for Cognitive Behavioural Therapy for Insomnia: an initiative of the European Insomnia Network to promote implementation and dissemination of treatment. *J Sleep Res* 2020; 29: e12967.

[4]. Riemann D, Baglioni C, Bassetti C, et al. European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia. *J Sleep Res* 2017; 26: 675–700.

[5]. Maire M, Linder S, Dvořák C, et al. Prevalence and management of chronic insomnia in Swiss primary care: cross-sectional data from the “Sentinella” practice-based research network. *J Sleep Res* 2020; 29: e13121.

[6]. Simon L, Steinmetz L, Feige B, Benz F, Spiegelhalder K, Baumeister H. Comparative efficacy of onsite, digital, and other settings for cognitive behavioral therapy for insomnia: a systematic review and network meta-analysis. *Sci Rep* 2023; 13: 1929.

[7]. Bothelius K, Kyhle K, Espie CA, Broman JE. Manual-guided cognitive-behavioural therapy for insomnia delivered by ordinary primary care personnel in general medical practice: a randomized controlled effectiveness trial. *J Sleep Res* 2013; 22: 688–96.

[8]. Batterham PJ, Sunderland M, Cleave AL, et al. Developing a roadmap for the translation of e-mental health services for depression. *Aust N Z J Psychiatry* 2015; 49: 776–84.

[9]. Kyle SD, Siriwardena AN, Espie CA. Clinical and cost-effectiveness of nurse-delivered sleep restriction therapy for insomnia in primary care (HABIT): a pragmatic, superiority, open-label, randomised controlled trial. *Lancet* 2023; published online Aug 10. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)00683-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00683-9).

[10]. Maurer LF, Espie CA, Kyle SD. How does sleep restriction therapy work? A systematic review of mechanistic evidence and the introduction of the triple-R model. *Sleep Med Rev* 2018; 42: 127–138.

[11]. Alcántara C, Giorgio Cosenzo L, McCullough E, Vogt T, Falzon AL, Perez Ibarra I. Cultural adaptations of psychological interventions for prevalent sleep disorders and sleep disturbances: a systematic review of randomized controlled trials in the United States. *Sleep Med Rev* 2021; 56: 101455



首页



刷新



反馈



更多

[12]. Zhou ES, Ritterband LM, Bethea TN, Robles YP, Heeren TC, Rosenberg L. Effect of culturally tailored, internet-delivered cognitive behavioral therapy for insomnia in Black women: a randomized clinical trial. JAMA Psychiatry 2022; 79: 538–49.

题图 Copyright © 2023 Vuk Saric/Getty Images

中文翻译仅供参考，所有内容以英文原文为准。

免责声明：本内容来自腾讯平台创作者，不代表腾讯新闻或腾讯网的观点和立场。🔔 举报

新区刚开的传奇，800%爆率，1000%攻速，野怪也爆真充卡！

广告 传奇5首区-0氪福利拉满 [了解详情](#) ×



一个远被低估的助眠方法，睡前 10 分钟就管用！

丁香医生 6小时前



大脑衰退的睡眠陷阱：7.23小时，少了危险，多了更可怕！

阿尔茨海默公社 23评论 昨天



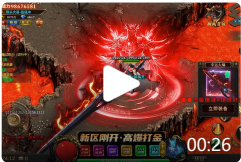
明明睡了8小时，还是没精神？你可能是慢性疲劳综合征，如何改善

快乐的小大夫 前天



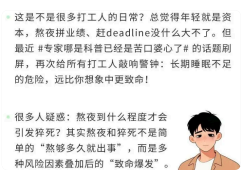
【氪佬勿扰】击杀小怪爆充值，散人0氪能霸服

广告 超变魔幻打金 [了解详情](#) ×



长期睡眠不足6小时，很危险！

医药养生保健报 2评论 前天



告别“情绪拐杖”，抗抑郁药的撤药之路

PSM药盾公益 昨天



告别安眠药！中国多中心研究证实厚被子显著改善失眠

路汀生命科学研究 39评论 昨天



帕金森患者如何应对药物引发的精神障碍

心理研究锁 2小时前



睡眠质量：优质睡眠对女性容颜的修复与提升

部分试看 777阅读



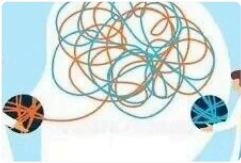
「领1赠1」最后7小时，每人2张【温州车展】门票，免费领取！

广告 悦展汇 [打开小程序](#) ×



心理治疗如何起效？改变“过去的负担”与“未来的引力”，就能重塑当下

精神科俞少华医生 19小时前



老年人周围神经病理性疼痛用药指南：抗癫痫类药物+抗抑郁类药物+阿片类镇痛药物+神经营养药物+...

巢内神经学界 21小时前
评论 0 文明上网理性发言，请遵守《新闻评论服务协议》





请先 [登录](#) 后发表评论~

已显示所有评论